SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

PACIENTE: Guilherme Holanda

Tema: Hiperfoco na infância (no momento personificando no aniversário do primo Rafael, vivências no condomínio Acauã, desejo pelo retorno do prepúcio antes da cirurgia, se refere a 'Guilherme e as crianças' para tratar de alguma situação que não sabemos se é real ou imaginária, tem fortes memórias do tempo da escola, assiste constantemente Xuxa no youtube)
Data: 19/11
Fonte dos dados: Sistema REDE (Módulos MAP, MAD e RAI) + Agente de Inteligência Artificial "LUCAS" + Relatos familiares + Relatos de profissionais

1. Contextualização Geral – Sistema REDE

O **Sistema REDE** é composto pelos módulos:

- **MAD – Rotinas domésticas:** acompanha dinâmicas familiares, padrões comportamentais em casa e rotinas cotidianas.
- **MAP – Atividades programáticas externas:** monitora respostas comportamentais e socioemocionais em escola, trabalho e lazer.
- **RAI – Rastreio de Ações Indesejadas:** identifica padrões de risco, escalada de estresse, sinais de crise iminente e gatilhos.

Os três módulos, em conjunto, permitem **monitorar mudanças emocionais, padrões de estresse e eventos gatilho**, gerando relatórios que auxiliam profissionais de saúde e educação na tomada de decisões. No caso específico de Guilherme, os três módulos apresentam informações convergentes indicando **a presença de um hiperfoco persistente**, associado a forte carga emocional, relacionado a **assuntos que remetem à infância - exemplo: aniversário do primo Rafael** (22/11), condomínio Acauã, prepúcio de antes da cirurgia.

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

2. Descrição do Problema – Síntese Técnica

2.1 Hiperfoco na infância

- Guilherme está apresentando um **hiperfoco persistente relacionado à infância**, com forte carga emocional.
- Ele revisita conteúdos infantis (como DVDs antigos), revisita memórias do **prédio Acauã**, e demonstra um esforço interno para **entender acontecimentos marcados como "inacabados"** na memória.
- Parte desse hiperfoco parece envolver **questões simbólicas de corpo e identidade**, percebidas como referências de infância.

2.2 Episódio significativo relatado (19/11)

Durante mediação após consulta urológica com o Dr. Gustavo Gentile, Guilherme expressou verbalmente: "Quero o pinto de criança."

Isso traz duas hipóteses clínicas importantes:

1. **Dificuldade de integração entre corpo atual e corpo infantil** – indício de conflito emocional, possível luto não elaborado da infância ou da imagem corporal.
2. **Simbolismo do prepúcio como marcador de infância** – não se trata apenas de um desconforto físico, mas de uma expressão emocional mais profunda.

Interpretação:
Esse comportamento deve ser entendido **sem julgamento**, como manifestação de um conflito identitário, emocional e simbólico. Requer exploração cuidadosa em psicoterapia e psiquiatria, considerando a baixa acessibilidade de comunicação para temas íntimos.

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

3. Comunicação e mediação

- Guilherme **não consegue se expressar plenamente** sobre emoções complexas, sexualidade, identidade corporal ou temas íntimos.
- Sylvia pode desempenhar o papel de **mediadora (AT)** durante atendimentos terapêuticos, ajudando a organizar a comunicação e traduzir necessidades que Guilherme ainda não verbaliza.
- É fundamental garantir que o processo de mediação:
  - Não substitua a voz de Guilherme;
  - Mas permita que a profissional compreenda nuances que ele ainda não consegue articular sozinho.

4. Repertório terapêutico atual

- **Musicoterapia**: Guilherme ama, participa ativamente e responde bem.
- **Psicoterapia e arteterapia**: recomendadas como essenciais para trabalhar memória emocional, narrativa de vida e conflitos internos relacionados à infância.

ANOTAÇÕES:

_____

_____

_____

_____

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

5. Comportamentos observados

5.1 Aspectos positivos

- Guilherme é **muito ativo**.
- Tem apresentado **evolução consistente em flexibilidade**, reduzindo rigidez em diversas rotinas.
- Engajamento elevado em atividades preferidas.

5.2 Desafios atuais

- **Hiperfoco intenso** (infância, DVDs, memórias fragmentadas).
- **Devaneios excessivos** ao longo do dia.
- **Seletividade alimentar**.
- **Comportamentos disruptivos** em situações de estresse.
- **Agressividade severa** em picos emocionais elevados.
- **Risco de mal-estar físico** em episódios de sobrecarga.

Esses indicadores são monitorados pelo módulo RAI e têm sido relevantes para identificar fases de maior vulnerabilidade emocional.

ANOTAÇÕES:

_____

_____

_____

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

6. Objetivo para a consulta com a psiquiatra

6.1 O que a família deseja?

- Garantir **bem-estar emocional e físico** de Guilherme.
- Reduzir sobrecarga, ansiedade e riscos de crises.
- Auxiliar Guilherme a **compreender suas próprias emoções**, especialmente:
  - Conflitos envolvendo “infância perdida”;
  - Memórias incompletas;
  - Percepção da própria sexualidade e corpo;
  - Medos ou angústias que ele ainda não verbaliza.

ANOTAÇÕES:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

6. Objetivo para a consulta com a psiquiatra

6.2 O que precisa ser investigado na avaliação psiquiátrica

A consulta poderá abordar:

1. **Significado do hiperfoco na infância**
   - É regulador emocional, busca de segurança, ou manifestação de conflito interno?
   - Há sofrimento associado?

2. **Expressão sobre querer o "pinto de criança"**

   - Avaliar como isso se relaciona com identidade corporal, maturidade emocional, sensação de perda ou regressão.
   - Verificar presença de angústia corporal (body-focused distress).

3. **Impacto funcional dos devaneios e hiperfoco**

   - Há prejuízos na rotina?
   - Há risco de fuga, impulsos, desatenção perigosa?

ANOTAÇÕES:

_____

_____

_____

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

6. Objetivo para a consulta com a psiquiatra

4. **Regulação emocional**
    - Episódios de agressividade e sobrecarga precisam de rastreio clínico:
        - ansiedade generalizada,
        - TEPT,
        - distúrbio afetivo,
        - sobrecarga sensorial,
        - e efeitos de eventos simbólicos mal resolvidos.
5. **Possível necessidade de ajustes medicamentosos**
    - Considerar suporte ansiolítico ou modulador de impulsividade, caso indicado por avaliação médica.
6. **Construção de rotinas integrais de suporte**
    - Como integrar psiquiatria, psicoterapia, musicoterapia, arteterapia e mediação.

ANOTAÇÕES:

_____

_____

_____

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

7. Questões sugeridas para levar à psiquiatra

Para compreensão emocional:

- Como identificar se o hiperfoco na infância está relacionado a sofrimento emocional?
- Como ajudar Guilherme a elaborar narrativas sobre sua infância?
- Como trabalhar a “sensação de perda” ou incompletude?

Sobre o corpo:

- Como interpretar clinicamente a fala sobre “pinto de criança”?
- Existe indicação de investigação sobre disforia corporal, regressão emocional ou trauma?
- Como abordar temas íntimos respeitando limites e promovendo segurança?

Sobre regulação do comportamento:

- O que pode explicar os episódios de agressividade em alto estresse?
- Tratamentos farmacológicos para reduzir essas crises?

Sobre rotinas terapêuticas:

- A psiquiatra recomenda incluir arteterapia, psicoterapia psicodinâmica, TCC adaptada, ou outro método?
- Como a mediadora (Sylvia) deve conduzir a comunicação em sessões?

SISTEMA REDE v1

RELATÓRIO DE TRIGGER (RT)

CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA MICHELLE MENDONÇA

8. Recomendação para apresentação na consulta

Levar:

- Este relatório impresso.
- Registros recentes do Sistema REDE (MAD, MAP, RAI).
- Descrição objetiva de episódios críticos dos últimos meses.
- Lista de medicamentos atuais, se houver.

9. Conclusão

A família busca **um caminho seguro para que Guilherme compreenda suas emoções**, especialmente os conflitos emergentes relacionados à infância e às transformações corporais. O objetivo maior é promover:

- **bem-estar**,
- **redução de estresse**,
- **clareza emocional**,
- **prevenção de crises**,
- **autonomia**,
- e **qualidade de vida**.

O relatório acima fornece à psiquiatra um panorama completo, para que a consulta seja produtiva e permita avanços reais no cuidado de Guilherme.